



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض رابعياً : راضية سليمان احمد عشماوي
المحافظة : الفيوم
الحى / المدينة : سنورس
رقم البطاقة : 28906252300729 رقم التليفون : 01221547479
العنوان : منشاه حلفا
العمر (تاريخ الميلاد) : 25-06-1989 المهنة : بدون عمل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 10-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مسح ذري علي العظام [12966] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: راضية سليمان احمد عشاوي National ID: 28906252300729	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bone scintigraphy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

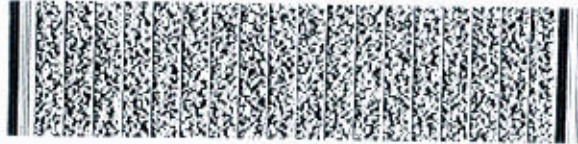


٢٠٢٣/١١ ٢٨٩.٦٢٥٢٣.٠٧٢٩

دبلوم صناعة



انتر ممثلة
عنى ادريس عبد الجيد السيد
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/١١/٢٢



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

راضيه

سليمان احمد عثمانوى

منشأة حلفا

مركز اطسا - الفيوم

١٩٨٩/٠١/٢٥

٢٨٩.٦٢٥٢٣.٠٧٢٩

KH0671335



Preventive Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الوقائي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



A-Patient ID:
1- Name:

إشيرة سلطان احمد عثمان

2-10 number: 28905252300729

Sex:

MDT form
3- Medical number:
Female

Patient Age: 34 Y.

83163507
Old Med I

3517-2023

Family history

Family history
+ve

Phone

Marital status

Marital status
MARRIED

NRS Score

Co morbidity

Co morbidity
free

Menopausal status

Phone
01091630165

BMI

NRS Score

Menopausal status
PREMENOPAUSE

GROUP

REASON OF MDT

Date of MDT

REASON
POST OP

DATE OF
2023

Breast Imaging:
LT Breast UOQ Q MBOC

Clinical data

Mets Workup:
CT chest RLV: ABRUF: FREE
CT PELVI: FREE

BX
IDC

ER
4/8

PR
0/8

Her 2 Neu
0

SYSH

K167
35

T
PT2

N
2

M
0

Sonamammography
CESM: UNIFOCAL

PATIENT HISTORY
upfront LT BCS+ALND:
free magins
LN 6/12 +ve

MDT OUTCOME & PLAN

for: Adjuvant Chemo ACx4 (attempt dose dense) then Taxol x12 then PORT
- Adjuvant TAMIZ. taxol as advised by Dr. Logy Karam.

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

Psychiatric

MEDICAL ONCOLOGY
دكتور
دكتور

SURGERY
دكتور

Psychiatric
دكتور

SIGNATURE

RADIOLOGY

PATHOLOGY

Nutrition

PATHOLOGY

PATHOLOGY

PATHOLOGY

Name: راضية سليمان احمد عشناوي		
MR. : 3283		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالتها		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها		
The patient was diagnosed in October 2023 with invasive ductal carcinoma, Grade II, involving the right breast with 6 of 12 axillary lymph nodes positive and free surgical margins. The tumor staged pT2, pN2 with accessory breast tissue involvement. The multidisciplinary team recommended adjuvant chemotherapy consisting of four cycles of dose-dense AC (doxorubicin and cyclophosphamide) followed by twelve cycles of taxane (paclitaxel). Post-operative radiotherapy was planned for the right breast (4 Gy in 8 fractions, 0 Gy in 8 fractions). The patient is HER2-negative, diabetic, and reports bony pain; consideration was given to discontinue hormonal therapy and to initiate Zoladex, tamoxifen, and zoledronic acid for bone protection. The next visit was scheduled for 15 October 2026, at which time the patient was to receive zoledronic acid, tamoxifen, and supportive care. In September 2026 the oncology team continued the bone-protective regimen with zoledronic acid, Zoladex, tamoxifen, and dexamethasone. A 12-month osteopenia assessment was noted, and a new bone scan was ordered to evaluate skeletal status. The patient remains on the current medication regimen and is under ongoing surveillance for disease status and bone health.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ : 21-09-2026
	نهي سعيد علي محمد	
الطبيب المعالج :		
يعتمد ,		

Patient Name : الأستاذ / راضيه سليمان احمد عثمانى	Request No. : 13002795
Patient No. : 28906252300729	Request Date : 07/10/2023
Path No. : 3408/23	Verification Date : 24/10/2023
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - مبداء
Age : 34 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data : Left breast cancer(up front)

Nature of the specimen : Left BCS & left ALN biopsy

Gross Examination:

• Procedure: Left BCS specimen measured 8x9 cm , covering skin ellipse measured 3 x 1 cm

• Tumor extent : A well defined greyish white firm mass measured 3x3x2cm .

• Distance from margins: 0.2 cm away from lateral margin , 0.5 cm away from medial margin .

• Lymph nodes number and size: A fibrofatty tissue piece measured 8x9x2 cm enclosing 12 ALNs up to 1.5x1 cm .

Frozen section: superior&inferior suspicious ,free extramargin

• accessory breast: fibrofatty tissue 9x9x3 cm ,collectively, showed greysih white streaks

Microscopic examination:

• Histological type: Invasive duct carcinoma

• Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)

• Angioinvasion: No

• Ductal carcinoma in situ: No

• Lymph node involvement: Positive ALNs (6/12)

• Resection Margins: Free margins

• Accessory breast: Microscopic examination revealed breast tissue with areas of adenosis

Diagnosis:

Left BCS & left ALN biopsy:

Invasive duct carcinoma Grade II

• Positive LNs (6/12)

• Free margins

• Stage : pT2 , pN2

- Accessory breast tissue

Prof. Dr. Gamal Abdelatty

Dr.Menna Nabil

Verified by :

Dr.Hoba Hasan



Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name	: الأستاذة / راضية سليمان أحمد عثمان	Request No.	: 13002795
Patient No.	: 28906252300729	Request Date	: 07/10/2023
Path No.	: 3408/23	Verification Date	: 24/10/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام داء السلام - مبادره
Age	: 34 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc	:	Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Verified by :
Dr. Heba Hasan

Printing Date : 24/10/2023 14:16:59

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (587) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor - Building No. 987 - Nile Corniche - Mizr El Qadema - Cairo, Egypt



Patient Name: Radia Sollman Ahmed Ashmawi	Date : 14/09/2023
Exam : C.T ABDOMEN & PELVIS	Age : 34 Year(s)
Medical ID: 3517/2023	Pat. ID: 41909

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Reported case of breast cancer

I Chest:-

- Left axillary level I and II pathologically enlarged lymph nodes the largest measuring 27 x 17 mm at level I , with left axillary tail soft tissue lesion seen measuring about 3x2cm.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitory lesions.
- No enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities on noncontrast.
- No Intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Small left adnexal cystic lesion mostly functional.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- No definite osteolytic or sclerotic lesions detected on the scanned skeleton.

Opinion:



Patient Name: Radia Soliman Ahmed Ashmawi	Date : 14/09/2023
Exam : C.T ABDOMEN & PELVIS	Age : 34 Year(s)
Medical ID: 3517/2023	Pat. ID: 41909

- **Reported case of breast cancer with left breast lesion and ipsilateral pathological axillary lymph nodes.**
- **No definite hepatic, pulmonary or osseous metastatic deposits on non-contrast basis.**

Dr. Mohammed Mofisen, MSc

Dr. Sherif Sameh, M.D.